

מעקב / ביקור אחר יולדת:**לידה נרתיקית –**

לאחר לידה נרתיקית

פנתה עם _____ והתקדמה ללידה תחת/ ללא אלחוש אפידורלי.

[לציין אם קרה משהו במהלך הלידה חום/ GBS וכל אירוע חריג]

לא הלידה קרע דרגה _____ נתפר במהלך תקין

בבדיקתה כעת חשה בטוב, ללא תלונות חריגות, מתניידת במחלקה, נותנת שתן ספונטני

סימנים חיוניים תקינים, ללא חום סיסטמי.

בטן רכה, רחם מכווץ. חיץ תקין, לוכיה תקינה

גפיים ללא סימני DVT.

_____ RH

המוגלובין _____ לפני הלידה.

[יש לחזור על HB במידה וקרע דרגה 3/4, המוגלובין התחלתי מתחת ל10, רביזין]

ניתוח קיסרי -

יולדת לאחר ניתוח קיסרי אלקטיבי/ דחוף

[אם אלקטיבי] בשל _____

[אם דחוף] איך הגיעה ולמה הוחלט לסיים בניתוח. מהלך הניתוח ולאחריו תקינים.

כעת שכובה, חשה בטוב, סימנים חיוניים תקינים ל"ד _____, דופק _____, בקטטר שתן צלול בכמות טובה

בטן רכה, רחם מכווץ היטב, צלקת ניתוחית חבושה - יבשה, לוכיה תקינה

גפיים ללא סימני DVT

סוג הדם RH _____

המוגלובין _____ גר% לפני הניתוח, המוגלובין לאחר הניתוח _____ גר%

לפי אומדן VTE אין / יש צורך בקלקסן

ביקור יולדת עם חשד לדימום.

לאחר לידה נרתיקית/ ניתוח קיסרי.

לאחר הלידה דווח על דימום מוגבר ____ טופלה ב ____ / קרע דרגה ____ .

בהערכת דימום בניתוח: _____

המוגלובין טרם הלידה/ ניתוח: ____ גר%, המוגלובין ____ גר% מיד לאחר מכן, כעת ____ גר%

היולדת מציינת / שוללת סחרחורת, חולשה, פלפיטציות.

בבדיקתה כעת ל"ד: _____ דופק: _____

בבדיקתה: בטן רכה לא רגישה רחם מכווץ היטב. לוכיה תקינה. ללא דימום מוגבר.

PR-I PV ללא המטומות.

US בטן: רחם מכווץ ללא שארית בתוכו. ללא עדות לנוזל חופשי בחלל הבטן.

סוג דם: _____

****מתחת להמוגלובין 7 אסימפטומטית - מנת דם.**

****המוגלובין 7-8 סימפטומטית לשקול מנת דם.**

טיפול במחלקה:**סוג דם אמהי RH NEGATIVE יילוד RH POSITIVE:**

טיפול ב 300 ANTI D מק"ג חד פעמי.

במקרה של: ניתוח קיסרי, רביזיו, תאומים – יש לטפל ב ANTI D במינון כפול 600 מק"ג.

חום בלידה / לאחריה:

חום במהלך הלידה – חשד לכוריואמיניטיס.

טיפול בטריאדה:

IV Penibrin 2gr * 4/d

IV Garamycin 80 mg * 3/d [after birth: IV: 240 mg*1/day]

IV Clindamycin 900 mg * 3/d

טיפול בטריאדה למשך 48 שעות לפחות, ניתן להפסיק טיפול במידה ואין חום במשך 24 שעות.

במידה ועדיין חום, המשך טיפול בטריאדה למשך 72 שעות.

זיהום בצלקת ניתוחית:

טיפול אוגמנטין: 825 מ"ג * 2 ביום למשך שבוע.

קרע דרגה 3 ומעלה:

אנטיביוטיקה IV במהלך הפעולה ובמשך 45 שעות לאחריה

יש לתת ביומיים הראשונים:

IV Flagyl 500mg*3/d; IV Rocephin 1gr*1/d

ובמשך 5 ימים נוספים:

PO Flagyl 500mg*3/d, PO Zinnat 500 mg*2/d

על מנת למנוע עצירות:

לקטולוז 15 סמ"ק פעמיים ביום למשך 7 ימים

סיקור לידה מוקדמת [מתחת לשבוע 37] –

בדיקות ל: Q FEVER, תרבויות דם.

במכתב שחרור לציין: נלקח סיקור לידה מוקדמת- עד כה ללא צמיחה.

המלצות בשחרור:**יתר ל"ד:**

המשך מעקב לחץ דם בבית שלוש פעמים ביום ותיעוד הערכים.
 בכל מקרה של מדידת ל"ד מעל 150/100 (אחד מהם), טשטוש ראייה, כאבים ברום הבטן, כאבי ראש, תחושה כללית רעה יש לפנות בהקדם לבדיקת רופא
 יש להשלים בירור קרישיות יתר לאחר תקופת משכב לידה
 ביקורת מרפאת הריון בסיכון וקבלת ייעוץ טרום הריוני לקראת ההריון הבא
 מומלץ טיפול באספירין במהלך ההריון הבא.

יילוד UGR:

יש להשלים בירור קרישיות יתר לאחר תקופת משכב לידה
 ביקורת מרפאת הריון בסיכון וקבלת ייעוץ טרום הריוני לקראת ההריון הבא

דיווח על מיומות:

במעקב רופא נשים - נא התייחסות לגבי המיומה הרחמית

קיצור צוואר בהריון:

מעקב הריון בסיכון לשקילת טיפול בפרוגרסטרון בהריון הבא.
 במידה והיה תפר צווארי בהריון נוכחי:
 מעקב הריון בסיכון מוקדם לשקילת אפשרות של תפר צוואר בהריון עתידי.

לידה מוקדמת:

לאור לידה מוקדמת בהריון נוכחי לשקול ייעוץ טרום/ מעקב הריון בסיכון
 ושקילת פרוגרסטרון בהריון הבא

קרע דרגה 3 ומעלה:

יש להשלים טיפול אנטיביוטי כמתואר ל 5 ימי טיפול עד _____ כולל
 להמשיך ליטול לקטולוז 15 סמ"ק פעמיים ביום למשך שבוע מהלידה.
 ביקורת במרפאה פרוקטולוגית ב _____, מרפאות חוץ רמב"ם. (נמסר זימון ליולדת)
 מומלץ לבצע פיזיותרפיה לרצפת אגן לפחות ל 3 חודשיים לאחר הלידה.
 בהריון עתידי יש לבצע דיון לגבי אופן הלידה בשל קרע _____ /
 מומלץ ללדת בניתוח קיסרי בלידות הבאות בשל קרע _____

דליות בגפיים:

במידה וניתן קלקסן במהלך האשפוז:
 מומלץ להמשיך טיפול בקלקסן בבית למשך שבועיים.

אבחנות בשחרור:

NORMAL DELIVERY	לידה נרתיקית:
EARLY ONSET DELIVERY-DELIVERED [להוסיף את השבוע בהערות]	לידה מוקדמת:
CESAREAN DELIVERY NOS-UNSP	ניתוח קיסרי:
DELIVERY-SINGLE LIVEBORN	יילוד בודד חי
DELIVERY-TWINS, BOTH LIVE	תאומים חיים
DELIVERY-MULTIPLE BIRTH, ALL LIVE	שלישיה ומעלה חיים
FORCEPS OR VACUUM DELIVERY NOS-DELIVERED	וואקום
PREMATURE RUPTURE OF MEMBRANE-UNS	ירידת מים
BREECH PRESENTATION - DELIVER	מצג עכוז
PYREXIA DURING LABOR-DELIVERED	חום בלידה:
AMNIOTIC INFECTION-DELIVERED	זיהום מוכח / חשוד:
CARRIER / SUSPECTED CARRIER OF GROUP B STREPTOCOCCUS	GBS:
CERVICAL SHORTENING, DELIVERED	קיצור צוואר בהריון
DELIVERY WITH ___ DEGREE LACERATION-DELIVERED	קרע בלידה
RETAINED PRODUCTS OF CONCEPTION	שארית שילייה
VARICOSE VEINS OF LEGS-POSTPARTUM	דליות
INFECTION SURGIC WOUND OF	זיהום בצלקת ניתוחית:
RETENTION OF URINE NEC [להוסיף resolved]	אצירת שתן במהלך האשפוז:
NON REASSURING FETAL HEART REATE	שלל אבחנות מקבלה
DECREASED FETAL MOVEMENTS, DELIVERED	
פעולות וטיפולים	
VACUUM EXTRACTION DELIVERY	וואקום
EPISIOTOMY	אפיזוטומיה
EPIDURAL BLOCK / ANESTHESIA	אפידורל
INJECT ANESTHETIC-SPINAL CANAL FOR ANALGESIA	ספינאלית
GENERAL ANESTHESIA	הרדמה מלאה
SURGICAL INDUCTION OF LABOR NEC	הפעלת לידה בלון
MEDICAL INDUCTION OF LABOR BY PGE2	הפעלת לידה פרופס
MEDICAL INDUCTION OF LABOR BY PITOCIN	הפעלת לידה פיטוצין
INDUCTION OF LABOR BY ARTIFICIAL RUPTURE OF MEMBRANE	פקיעת קרומים
MANUAL REMOVAL OF PLACENTA	הוצאה ידנית של השילייה
REVISIO UTERI - (MANUAL EXPLORATION OF UTERUS)	רביזיו
INJECT RH IMMUNE GLOBUL	טיפול ב ANTI D
TRANSFUSION PACKED CELLS	מנת דם
PLASMA TRANSFUSION	מנת FFP
INFUSION OF MAGNESIUM SULFATE	מגנזיום